Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Dourados
2ª Vara Cível

SENTENÇA

VISTOS E EXAMINADOS estes **Autos n° 0802927-50.2024.8.12.0002** em que é Autor(a) **Karollayne Pavão Barbosa** e é Ré **UNIMED DE DOURADOS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e ALLCARE GESTORA DE SAÚDE**

Karollayne Pavão Barbosa, qualificada na petição inicial, através de advogada constituída, ingressou com esta *Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais*, pleiteando a concessão de liminar, a título de antecipação dos efeitos da tutela de mérito, contra **Unimed Norte de Minas** e **Allcare Gestora de Saúde,** igualmente qualificadas.

Pleiteia, discorrendo acerca da verossimilhança da alegação e do perigo de dano, a concessão de liminar determinando a manutenção do vínculo contratual entre as partes, com as mesmas coberturas, assegurando *"a cobertura dos custos médico-hospitalares durante o pré-natal, parto e ainda a garantia do ingresso do recém-nascido, tão logo seu nascimento, como dependente da Autora no plano de saúde, sem exigência de carência e sem restrição de cobertura durante o primeiro mês" (sic),*

Aduz ter ingressado no plano do contrato coletivo por adesão, de abrangência nacional (plano ambulatorial hospitalar com obstetrícia), celebrado, em 21/março/2023, tendo como estipulante, a Servix Administradora de Benefícios Sociedade Simples e como operadora a Unimed Montes Claros Cooperativa de Trabalho Médico Ltda, com início de vigência desde 14/abril/2023.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LARISSA DITZEL CORDEIRO AMARAL, liberado nos autos em 28/09/2024 às 09:41 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802927-50.2024.8.12.0002 e código JoToWerH.

Menciona ter recebido no dia 10/junho/2023 uma mensagem via SMS da **Servix Administradora de Benefícios Sociedade Simples** informando-lhe que o plano passaria a ser administrado pela segunda Ré, **Allcare Gestora de Saúde.**

Conta ter sido, em 17/outubro/2023, confirmada sua gravidez através de exame de ultrassonografia obstétrica inicial, que estabeleceu como data provável do parto o dia 04/junho do ano em curso.

Relata que apesar de estar sob acompanhamento pré-natal e em dia com as mensalidades do plano, em 20/março do ano em curso, foi surpreendida com a informação de que a primeira Ré "havia unilateral e injustificamente rescindido contratos com seus clientes/usuários do Estado do Mato Grosso do Sul" (sic) e, ao contatar a segunda Ré, foi por ela informada de que seu contrato de prestação de serviços seria encerrado a partir do dia 10/abril/2024 (fls. 54).

Defende o abuso da medida adotada pelas Rés, porquanto, embora se trate de plano de saúde coletivo, a rescisão unilateral viola a legislação vigente e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, reconhecida pelo Tema Repetitivo nº 1082, e ignora a *"imprescindibilidade da continuidade do tratamento multidisciplinar e da investigação de outras comorbidades" (sic).*

Assim expondo, após discorrer sobre os requisitos legais, pleiteou a concessão de liminar e, ao final, a procedência de sua pretensão para torna-la definitiva, com a condenação das Rés ao pagamento de valor a ser arbitrado judicialmente, a título de indenização por danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios. Protestou genericamente por provas. Atribui à causa o valor de R$ 12.664,00, juntou documentos e emendou a inicial (fls.63 e 67/89).

Concedida a liminar (fls. 90/101), contra esta decisão a Ré Allcare interpôs agravo de instrumento (fls. 132 e 137/172), ao qual foi negado provimento pelo juízo *ad quem* (fls. 505/514)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LARISSA DITZEL CORDEIRO AMARAL, liberado nos autos em 28/09/2024 às 09:41 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802927-50.2024.8.12.0002 e código JoToWerH.

Efetivadas as citações (fls. 121/122), as Rés se fizeram representar nos autos (fls. 109/120, 177/178, 181/182, 231/232 e 343), ofertando, após infrutífera tentativa de conciliação (fl. 179), contestação (fls. 188/228 e 312/342).

A **Allcare Administradora de Benefícios de São Paulo Ltda,** suscita, ***preliminarmente***, sua ilegitimidade passiva *ad causam*, uma vez que, na condição de administradora de benefícios, não possui competência e/ou poderes para reativar o plano de saúde da Autora e/ou prestar-lhe "qualquer atendimento médico para o procedimento solicitado" (verbis), sobretudo por não ser uma operadora de planos de saúde e não prestar serviços de saúde aos beneficiários da Unimed.

No ***mérito***, propriamente dito, defende a improcedência do pedido inaugural atribuindo à Unimed Norte de Minas a responsabilidade exclusiva pela rescisão unilateral da avença, porquanto, a despeito de ter passado a representar[1], a partir de 01/julho/2023, uma carteira com 15.426 beneficiários de planos coletivos há muito celebrados com a Unimed Montes Claros Cooperativa de Trabalho Médico – Unimed Norte de Minas, em 11/março do ano em curso, foi por ela notificada acerca da rescisão unilateral dos beneficiários, com previsão do término de vigência para 10/abril do ano em curso e, apesar de te-la contra-notificado, inclusive alertando sobre a necessidade de cumprimento dos prazos e regras contratuais previamente estabelecidos com esses beneficiários, a operadora Ré se manteve irredutível, o que "*representa uma grave infração regulatória e um risco assistencial a milhares de vidas sem precedentes" (sic).*

Aponta o descumprimento pela operadora das Resoluções Normativas da ANS nº 557/22 e 566/22 e defende o direito de garantia de cobertura assistencial aos beneficiários em tratamento continuado, ancorando-se no Tema repetitivo 1.082 do STJ.

Atribui má-fé à conduta da operadora Ré por enviar à sua revelia *"comunicado diretamente a todos os beneficiários prestando informações falsas e ilegais"* (sic), sobretudo por alegar ter-lhe comunicado, em 15/dezembro/2023, acerca da referida rescisão contratual,

[1] na condição de administradora de benefícios

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LARISSA DITZEL CORDEIRO AMARAL, liberado nos autos em 28/09/2024 às 09:41 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802927-50.2024.8.12.0002 e código JoToWerH.

ignorando que, em meados de janeiro/2024, havia revogado aquele ato;

Sustenta que, a simples determinação pela operadora Ré do reajuste contratual de 22,78% aos contratos com previsão de aniversário em fevereiro/2024, por si só já evidencia, revogação, ainda que tácita, da notificação que lhe fora enviada em 15/dezembro/2023, de modo a prevalecer a manutenção de vigência contratual.

Menciona que embora tenha, em 25/março do ano em curso, apresentado denúncia junto à ANS sobre o ocorrido e intimado, em caráter de urgência[2], a operadora Ré para uma reunião, já realizada em 03/abril, nela registrando *"a obrigação de manutenção da assistência e a obrigatoriedade de a requerida respeitar os contratos e os direitos dos beneficiários, além de que seja garantido o exercício da portabilidade especial" (sic),* não obteve dela qualquer retorno;

Pontua que, a despeito de ter notificado a operadora Ré para que suspendesse a decisão de interrupção da assistência aos beneficiários, ela manteve sua decisão que previa para o dia 10/abril do ano em curso, a interrupção dos atendimentos.

Por fim, defende a ausência de conduta ilícita capaz de justificar a indenização pleiteada, não só por ter tentando, sem êxito, convencer a operadora Ré a mudar seu intento[3] como também por tê-la denunciado junto à ANS, além de ter comunicado a própria Autora sobre a decisão unilateral tomada pela operadora Ré informando sobre o seu direito de obtenção de portabilidade e disponibilização de planos particulares. Protesta genericamente por provas e requer que todas as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Fernando Machado Bianchi, OAB/SP 177.046, sob pena de nulidade. Anexa documentos (fls. 233/311).

A **Unimed Montes Claros Cooperativa Trabalho Médico Ltda**, suscita, ***preliminarmente***, sua ilegitimidade passiva *ad causam*, sob o argumento de que a Autora mantém vínculo contratual com a Administradora de Benefícios Allcare, empresa esta responsável pela

[2] *diante da gravidade dos fatos*
[3] *não rescindir unilateralmente os contratos protegendo os interesses dos beneficiários*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LARISSA DITZEL CORDEIRO AMARAL, liberado nos autos em 28/09/2024 às 09:41 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802927-50.2024.8.12.0002 e código JoToWerH.

contratação de plano de saúde no mercado para o grupo de beneficiários a ela vinculado, nos termos do a RN nº 515/2022, inexistindo *"qualquer relação direta da operadora com a beneficiária/Autora" (verbis).*

No ***mérito***, defende a improcedência do pedido inaugural, seja pela possibilidade de rescisão unilateral dos contratos oriundos de planos coletivos, ancorando-se nos artigos 13, PU, II da Lei 9.656/98 e 473 e 474 do Código Civil, na jurisprudência do STJ, na cláusula do Tema XV do contrato celebrado entre a Unimed Montes Claros e a Servix, posteriormente cedido à Allcare, e na Resolução Normativa nº 509, anexo I, da ANS; seja diante da ausência de vínculo contratual com a Autora, uma vez que esta aderiu a plano coletivo de saúde diretamente da Servix Administradora de Benefícios que, por sua vez, passou a ser administrado, posteriormente, pela Allcare Administradora de benefícios; seja, finalmente, por terem sido observados todos prazos contratuais e legais antes da efetivação da rescisão contratual, inclusive por ter sido oportunizado à beneficiária, exercer o direito de portabilidade.

Preconiza, ainda, a inaplicabilidade do Tema 1.082 do STJ, uma vez que a Autora não se encontra internada e/ou em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência e/ou de sua incolumidade física, porquanto sua gravidez *"é regular sem qualquer caracterização de urgência ou emergência" (sic).*

Por fim, impugna o pedido de inversão do ônus da prova por ausência dos requisitos autorizadores e pede a aplicação de eventual verba de sucumbência dentro dos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §2º, do CPC. Protesta pela produção de prova testemunhal e documental e genericamente por outros meios de provas. Junta documentos (fls. 343/501).

Sobreveio manifestação da Autora refutando os argumentos expendidos nas respostas, reiterando a procedência de sua pretensão (fls. 517/537 e 538/549).

Concedida oportunidade para especificação de provas (fls. 553/555, 556/567 e 568/571), retornaram, em seguida, os autos conclusos

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LARISSA DITZEL CORDEIRO AMARAL, liberado nos autos em 28/09/2024 às 09:41 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802927-50.2024.8.12.0002 e código JoToWerH.

para sentença.

É o Relatório. Passo a DECIDIR.

Trata-se de *Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer* proposta por **Karollayne Pavão Barbosa** contra **Unimed Norte de Minas** e **Allcare Gestora de Saúde**.

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra haja vista tratar-se de matéria exclusivamente de direito que dispensa a produção de provas em audiência por ser a documentação acostada aos autos suficiente para a análise de mérito, à semelhança do disposto no art. 355, I do Código de Processo Civil.

2. - A legitimidade jurídica, como uma das condições da ação, é investigada no plano abstrato, quando, então, se analisa, num primeiro momento, tão-somente se, de acordo com a narrativa feita na petição inicial, a suposta relação jurídica entre as partes é suficiente para submeter uma delas à vontade da outra. Ausente esta possibilidade, extingue-se o processo, sem resolução de mérito. Contudo, evidenciada esta possibilidade, a ação segue seu curso até que, após regular instrução, sobrevenha sentença acolhendo ou não a pretensão autoral, acaso tenha logrado provar ou não o fato constitutivo de seu direito.

Com efeito, a investigação das condições da ação submete-se ao crivo de Teoria da Asserção. Ao tratar da questão da legitimidade das partes, **José Carlos Barbosa Moreira**, leciona[4]:

"O exame da legitimidade, pois como o de qualquer das condições da ação – tem de ser feito com abstração das possibilidades que, no juízo de mérito, vão deparar-se o julgador: a de proclamar existente ou a de declarar inexistente a relação jurídica que constitui a res in judicio deducta. Significa isso que o órgão judicial, ao apreciar a legitimidade das partes, considera tal relação jurídica in statu assertionis, ou seja, à vista do que se afirmou. Tem ele de raciocinar como que admita, por hipótese, e em caráter provisório, a veracidade da narrativa, deixando

[4] *in Tutela Jurisdicional. São Paulo: Atlas, n. 17, p. 103.*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LARISSA DITZEL CORDEIRO AMARAL, liberado nos autos em 28/09/2024 às 09:41 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802927-50.2024.8.12.0002 e código JoToWerH.

para a ocasião própria o juízo de mérito a respectiva apuração, ante os elementos de convicção ministrados pela atividade instrutória."

A propósito, a jurisprudência do e. STJ:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO E DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL INDENIZÁVEL E LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REVER A CONCLUSÃO A QUE CHEGOU A CORTE DE ORIGEM DEMANDA O REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 7/STJ. (...) 3. ***A jurisprudência deste Superior Tribunal é uníssona ao adotar "a teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação, entre elas a legitimidade ativa, é apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação"*** *(AgInt no AREsp 948.539/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 03/11/2016). 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO".* (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.048.161/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, J. 28/11/2022, DJe de 13/12/2022)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO ANTE O ÓBICE DA SÚMULA 182/STJ. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDANTES. 1. Afastamento do óbice da Súmula 182/STJ dada a impugnação adequada dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade com a análise, de plano, do recurso subjacente. 2. ***Conforme jurisprudência desta Corte Superior, o exame das condições da ação, aí incluída a legitimidade para a causa, deve ser aferida com base na teoria da asserção (em abstrato), isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial****. Incidência da Súmula 83/STJ. 2.1. A análise acerca da efetiva existência ou não de vínculo jurídico entre as partes, bem como o alcance da responsabilidade decorrente da legitimidade de cada contendor, para fins de acolhimento ou rejeição dos pedidos diz respeito ao exame do mérito, a ser realizado com base no conjunto probatório*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LARISSA DITZEL CORDEIRO AMARAL, liberado nos autos em 28/09/2024 às 09:41 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802927-50.2024.8.12.0002 e código JoToWerH.

constante dos autos. 2.2. Não incide a preclusão, em relação ao exame das condições da ação para a análise, inclusive de ofício, realizada pelas instâncias ordinárias acerca de matérias de ordem pública. 3. Para derruir as conclusões da Corte local, acerca da ilegitimidade e consequente ausência de responsabilidade da seguradora na espécie, seria necessário promover o revolvimento do acerto fático-probatório e a interpretação de instrumentos particulares, sendo estas providências vedadas pelos óbices da Súmulas 5 e 7/STJ. 4. Agravo interno acolhido para reconsiderar a deliberação monocrática e, em nova análise do recurso subjacente, conhecer do agravo e, de plano, negar provimento ao recurso especial". (AgInt no AREsp n. 2.106.615/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, 4ª Turma, J. 28/11/2022, DJe de 2/12/2022)

Na hipótese, a alegação autoral de que houve falha e/ou abuso por parte das Rés na prestação dos serviços contratados, na medida em que teria sido surpreendida, em março do ano em curso, com a informação de que a primeira Ré *"havia unilateral e injustificadamente rescindido contratos com seus clientes/usuários do Estado de Mato Grosso do Sul" (sic)* e posteriormente informada pela segunda Ré de que seu contrato de prestação de serviços seria encerrado a partir do dia 10/abril/2024, a despeito de se encontrar em acompanhamento de seu pré-natal, é suficiente para coloca-las no polo passivo desta ação manejada com o escopo de compeli-las à manterem as coberturas do plano de saúde contratadas e a indeniza-la à reparação dos danos experimentados. Por óbvio, a procedência da pretensão autoral dependente da comprovação do fato constitutivo de seu direito e da ilegalidade da(s) conduta(s) perpetrada(s) pela Ré, a serem analisadas no mérito, sem que se avente, a esta altura, sobre eventual *ilegitimidade jurídica ativa ou passiva ad causam*.

Ad argumentandum tantum, não há nenhuma dúvida de que a relação entre as partes é de consumo, nos termos, inclusive, do enunciado da Súmula nº 608 do Colendo STJ[5]. Logo, o presente feito deve sujeitar-se ao regramento próprio do Código de Defesa do Consumidor, cujo artigo 18 não deixa dúvidas: o fornecedor é solidariamente responsável por defeitos do produto e/ou dos serviços, tais como os reclamados pela Autora.

---

[5]. *Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018)*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LARISSA DITZEL CORDEIRO AMARAL, liberado nos autos em 28/09/2024 às 09:41 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802927-50.2024.8.12.0002 e código JoToWerH.

No conceito de fornecedor posto no Código Consumerista, e para efeito do disposto no artigo acima referido, estão equiparados e respondem de forma objetiva e solidária os membros da cadeia de fornecimento dos respectivos serviços.

Isto porque na condição de administradora, a Allcare atua como prestadora de serviços em conjunto com a operadora Unimed Norte de Minas , na cadeia de relação de consumo e, por isso, ambas respondem solidariamente, nos termos do disposto nos artigos 7º, parágrafo único, 25, § 1º e 34 do CDC, in verbis:

Art. 7. (...) Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

Art. 25. (...) § 1º Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.

Art. 34. O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.

Como bem pontua a doutrina pátria ao comentar os dispositivos suso referidos:-

"A norma estipulou expressamente a responsabilidade solidária, em conformidade com a lei substantiva pátria, deixando firmada a obrigação de todos os partícipes pelos danos causados, nos moldes também do Código Civil (...). ***Isso significa que o consumidor pode escolher a quem acionar um ou todos. Como a solidariedade obriga a todos os responsáveis simultaneamente, todos respondem pelo total dos danos causados****"* [6]

[6] (RIZATTO NUNES, "Comentários ao Código de Defesa do Consumidor", 3ª ed., Saraiva, São Paulo, 2007, p. 159, item 4).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LARISSA DITZEL CORDEIRO AMARAL, liberado nos autos em 28/09/2024 às 09:41 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802927-50.2024.8.12.0002 e código JoToWerH.

Num outro prisma, não é exagero concluir que esse comando normativo tem por escopo, ainda, a proteção legal da relações contratuais marcadas pela multiplicidade de vínculos, pessoas e operações, visando atingir um fim econômico unitário, mediante a indução do consumo em massa de bens ou serviços. São os denominados contratos "coligados" e ou de de natureza "coligada", por integrarem uma mesma transação comercial global. Logo, por integrarem a mesma cadeia de consumo, de forma coligada ou não, a responsabilidade das operadoras e administradoras de planos de saúde sempre será solidária.

Corroborando essa linha de entendimento colaciono recentes precedentes do e. TJSP:-

*APELAÇÃO – **Planos de saúde – Ilegitimidade passiva alegada – Bradesco Saúde que atua em conjunto com a AllCare, não sendo possível, máxime pela relação de consumo, afastar a responsabilidade solidária –** Cancelamento unilateral do plano pela falta de envio de boletos – Falha da operadora que não pode prejudicar o consumidor – Manutenção do contrato corretamente decretada - Sentença mantida - Honorários advocatícios – Desprovimento que torna imperiosa a majoração da verba para 12% do valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, § 11, do CPC, ressalvada a concessão do benefício da gratuidade – Recurso desprovido, com dispensa da sustentação oral. (TJSP - Apelação Cível nº 1091395-47.2023.8.26.0100. Relator Domingos de Siqueira Frascino. Julgamento em 25/09/2024)*

*Apelação - Plano de saúde Cancelamento do plano - Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada de urgência - Autor em tratamento de câncer e doença de crohn- Sentença de procedência - Insurgência das corrés- **Administradora e operadora que integram a mesma cadeia de consumo - Solidariedade - Parceria contratual diante do consumidor- Cancelamento unilateral vedado** - Beneficiário em tratamento médico de doença grave, necessitando de tratamento contínuo, sem previsão de alta - Aplicação do art. 13, par. único, III, da Lei n. 9.656/98 extensível aos contratos coletivos por adesão e a teor do entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça sob rito dos recursos repetitivos (Tema 1082) - Necessário restabelecimento do plano de saúde até a efetiva alta, mediante o pagamento integral da mensalidade*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LARISSA DITZEL CORDEIRO AMARAL, liberado nos autos em 28/09/2024 às 09:41 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802927-50.2024.8.12.0002 e código JoToWerH.

- Recursos desprovidos (TJSP - 6ª Câmara de Direito - Apelação nº 1076693-62.2024.8.26.0100. Relator Ramon Mateo Júnior. Julgamento em 26/09/2024).

"Plano de saúde. Contrato coletivo. Cancelamento unilateral pela operadora. Usuária em tratamento médico. Impossibilidade de interrupção do atendimento. Cabimento da manutenção da cobertura até a alta médica. *Tese firmada pelo STJ (Tema 1082). Precedentes.* ***Legitimidade passiva da operadora reconhecida.*** *Sentença mantida. Recursos improvidos.x Apelação Cível 1007970-19.2023.8.26.0005; Relator (a): Augusto Rezende (TJSP - 1ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 3ª Vara Cível. Data do Julgamento: 18/06/2024; Data de Registro: 18/06/2024).*

Destarte, rejeito preliminar de ilegitimidade arguida pelas Rés.

3. - No mérito, a pretensão da Autora, já antecipada com o deferimento da liminar, é compelir as Rés, operadora e administradora de seu plano de saúde, respectivamente, a manterem o vínculo contratual entre as partes, com as mesmas coberturas, assegurando *"a cobertura dos custos médico-hospitalares durante o pré-natal, parto e ainda a garantia do ingresso do recém-nascido, tão logo seu nascimento, como dependente da Autora no plano de saúde, sem exigência de carência e sem restrição de cobertura durante o primeiro mês" (sic)*, e a reparação dos danos de ordem imaterial.

Argumenta, em síntese, a rescisão unilateral viola a legislação vigente e o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo nº 1082), ao ignorar a imprescindibilidade da continuidade de seu tratamento e/ou acompanhamento pré-natal incluindo consultas médicas, exames, procedimento cirúrgico da cesárea e assistência neonatal a que faz jus com o plano contratado.

As RR, por sua vez, defendendo teses opostas, tentam eximir-se de responsabilidade, atribuindo uma à outra a obrigação de

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LARISSA DITZEL CORDEIRO AMARAL, liberado nos autos em 28/09/2024 às 09:41 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802927-50.2024.8.12.0002 e código JoToWerH.

reparar eventuais danos experimentados pela Autora: a primeira, defendendo a legitimidade de sua conduta, a ausência de vínculo contratual com a Autora, a possibilidade a rescisão unilateral dos contratos oriundos de planos coletivos e a não incidência do Tema Repetitivo 1.082 do STJ enquanto que, a segunda, não só defende o descumprimento pela operadora das Resoluções Normativas da ANS nº 557/22 e 566/22 e o direito de garantia de cobertura assistencial aos beneficiários em tratamento continuado, de acordo com a tese firmada através do Tema repetitivo 1.082 do STJ, como também, aponta má-fé e "grave infração regulatória" na conduta da operadora Ré.

A relação contratual existente entre as partes está sujeita às regras protetivas do diploma consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º daquele diploma.

Se tanto já não bastasse, o artigo 35-G, da Lei nº 9.656/98, prevê expressamente a submissão dos contratos entre usuários e operadoras de planos de saúde, às disposições da Lei nº 8.078/90, ainda que aquele figure como beneficiário em avença celebrada entre pessoas jurídicas.

Finalmente, a questão é objeto da Súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça: "*Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde*".

A atividade das operadoras de plano de saúde como um todo está abrangida pelo Código de Defesa do Consumidor, consoante dispõe o artigo 3º, § 2º[7], e, consequentemente, as disposições contratuais daí decorrentes, devem obedecer às regras dispostas na legislação consumerista, destinadas que são a manter o equilíbrio entre as partes, especialmente em virtude da hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor.

O deslinde da lide é singelo e demanda, apenas, a identificação da possibilidade ou não de manutenção da Autora no plano

[7] CDC - Art. 3° (...)

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LARISSA DITZEL CORDEIRO AMARAL, liberado nos autos em 28/09/2024 às 09:41 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802927-50.2024.8.12.0002 e código JoToWerH.

de saúde administrado pela segunda e operado pela primeira e a responsabilidade desta por eventual prejuízo de ordem imaterial experimentado.

Antes de mais nada, é de bom alvitre destacar que a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo ou particular depende de prévia notificação do beneficiário em prazo não inferior a 60(sessenta) dias[8] (art. 13, PU, II, da Lei 9.656/1998), uma vez que a própria lei que rege os planos e seguros de saúde não impede a rescisão unilateral da avença, sobretudo na hipótese de inadimplência do segurado.

É importante pontuar, ainda, que no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ), foram estabelecidos nos últimos anos vários precedentes sobre a possibilidade de cancelamento e/ou rescisão unilateral em relação aos planos individuais ou familiares e aos planos coletivos[9] .

Em relação **aos planos individuais e familiares**, a possibilidade de rescisão unilateral pela operadora está relacionada ao descumprimento contratual por parte do beneficiário, na medida em que a própria norma do artigo 13, PU, inciso II, da Lei 9.656/98 **proíbe a suspensão ou a rescisão unilateral dessa modalidade de contratação**, exceto nos casos de fraude ou inadimplemento[10] por mais de 60 dias consecutivos ou não, nos últimos 12 meses de vigência do contrato – desde que o consumidor tenha sido notificado até o quinquagésimo dia da inadimplência. Atrelado a isso *"a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular"*. É o que se extrai do teor do dispositivo suso referido:-

Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

---

[8] de acordo com as regras estabelecidas pela ANS e pela Lei Federal que rege os planos e seguros privados de assistência à saúde
[9] *em que geralmente há intermediação da contratação pelo empregador ou entidade de classe*
[10] *não pagamento da mensalidade*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LARISSA DITZEL CORDEIRO AMARAL, liberado nos autos em 28/09/2024 às 09:41 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802927-50.2024.8.12.0002 e código JoToWerH.

Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

I - [...]

II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência; e

III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular

Saliente-se, por oportuno, que essa limitação ao cancelamento unilateral dos planos individuais, alcança também **as modalidades familiares de contratação**, conforme entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça no AREsp 1.721.518. Confira-se:-

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONJUGADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. ***PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE FAMILIAR. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. REVISÃO.*** *SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O recurso especial que indica violação do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, mas traz somente alegação genérica de negativa de prestação jurisdicional, é deficiente em sua fundamentação, o que atrai o óbice da Súmula nº 284/STF, aplicada por analogia. 3. Aplica-se o artigo 13, II, da Lei nº 9.656/1998 aos contratos de plano de saúde na modalidade familiar, sendo vedada a rescisão unilateral pela operadora. 4. Na hipótese, o acolhimento da pretensão recursal, a fim de reconhecer que o contrato firmado entre as partes é de natureza coletiva e que a usuária foi regularmente notificada pela operadora, implicaria o reexame de cláusulas contratuais e do contexto fático-probatório, procedimentos*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LARISSA DITZEL CORDEIRO AMARAL, liberado nos autos em 28/09/2024 às 09:41 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802927-50.2024.8.12.0002 e código JoToWerH.

inadmissíveis em recurso especial, nos termos das Súmulas nºs 5 e 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1721518 - SP (2020/0156994-8) RELATOR : MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA. Julgamento em 14/02/2022)

Noutro vértice, é entendimento há muito consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça que **o óbice à rescisão unilateral e imotivada dos contratos de planos de saúde não alcança os planos coletivos**, por ausência de previsão legal, desde que, evidentemente, respeitada a vigência mínima de 12(doze) meses e a prévia notificação dos usuários, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. Confira-se:-

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DECLARATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA. [...] ***2. O disposto no art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98 aplica-se exclusivamente às avenças de cunho individual ou familiar. Logo, admite-se a resilição unilateral e imotivada de contratos de plano de saúde coletivos, mediante prévia comunicação à contratante.*** *Precedentes desta Corte. 3. Agravo regimental desprovido.(STJ - AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.324.513 - SP (2012/0102796-9). Relator Ministro Marco Buzzi. Julgamento em 21 de fevereiro de 2019*

*[...]****De acordo com precedente deste Colegiado, o art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/98, que veda a resilição unilateral dos contratos de plano de saúde, não se aplica às modalidades coletivas, tendo incidência apenas nas espécies individuais ou familiares****. Precedentes das Turmas da Segunda Seção do STJ (REsp n. 1.776.047/SP, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/4/2019, DJe 25/4/2019)*

*[...]****Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos podem ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias*** *(art. 17, parágrafo único, da RN nº 195/2009 da ANS).* ***A vedação de suspensão e de rescisão unilateral prevista no art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998 aplica-se somente aos contratos individuais ou familiares*** *(REsp*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LARISSA DITZEL CORDEIRO AMARAL, liberado nos autos em 28/09/2024 às 09:41 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802927-50.2024.8.12.0002 e código JoToWerH.

1471569/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 07/03/2016)

*AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA. PRAZO OBEDECIDO. 1.**Havendo previsão contratual, admite-se a rescisão unilateral do contrato coletivo de saúde após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.** 3.Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1721970/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2018, DJe 29/10/2018)*

*AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. RAZÕES DO AGRAVO INTERNO QUE NÃO IMPUGNAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. 1. **É possível a resilição unilateral do contrato coletivo de saúde, uma vez que a norma inserta no art. 13, II, b, parágrafo único, da Lei 9.656/98 aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares.** Precedentes. 2. É inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (CPC/2015, art. 1.021, § 1º). 3. Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (AgInt no REsp 1722940/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018)*

A própria Lei nº 9.656/98 estabelece as **três espécies de regime ou tipo de contratação de plano ou seguro de assistência à saúde**, quais sejam: individual ou familiar; coletivo empresarial e coletivo por adesão (ex vi do art. 16[11], VII[12], alíneas, alíneas a, b e c).

[11] *Art. 16. Dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei devem constar dispositivos que indiquem com clareza:*
[12] *VII - o regime, ou tipo de contratação: a) individual ou familiar; b) coletivo empresarial; ou c) coletivo por adesão;*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LARISSA DITZEL CORDEIRO AMARAL, liberado nos autos em 28/09/2024 às 09:41 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802927-50.2024.8.12.0002 e código JoToWerH.

Com base na atribuição que lhe foi conferida pelo art. 4º, II e X, da Lei 9.961/2000, a Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, regulamentou as características dessas três espécies de contratos privados de assistência à saúde vigentes, através da edição da **Resolução Normativa 195, de 14/julho/2009,** atualmente revogada pela de **nº 557**[13], **de 14 de dezembro de 2022,** cujas principais características e definições podem ser encontradas nos artigos 5º, 9º, 15 e 16, *in verbis*:-

Art. 5º Plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial é aquele que oferece cobertura da atenção prestada à população delimitada e vinculada à pessoa jurídica por relação empregatícia ou estatutária.

§1º O vínculo à pessoa jurídica contratante poderá abranger ainda, desde que previsto contratualmente:

I - os sócios da pessoa jurídica contratante;

II - os administradores da pessoa jurídica contratante;

III - os demitidos ou aposentados que tenham sido vinculados anteriormente à pessoa jurídica contratante, ressalvada a aplicação do disposto no caput dos artigos 30 e 31 da Lei nº 9.656, de 1998;

IV – os agentes políticos;

V – os trabalhadores temporários;

VI – os estagiários e menores aprendizes; e

VII - o grupo familiar até o terceiro grau de parentesco consanguíneo, até o segundo grau de parentesco por afinidade, cônjuge ou companheiro dos empregados e servidores públicos, bem como dos demais vínculos dos incisos anteriores.

§2º O ingresso do grupo familiar previsto no inciso VII do §1º deste artigo dependerá da participação do beneficiário titular no contrato de plano privado de assistência à saúde..

Art. 9º O empresário individual poderá contratar plano

---

[13] *que Dispõe sobre a classificação e características dos planos privados de assistência à saúde e regulamenta a sua contratação, dispõe sobre a contratação de plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial por empresário individual e dispõe sobre os instrumentos de orientação para contratação de planos privados de assistência à saúde*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LARISSA DITZEL CORDEIRO AMARAL, liberado nos autos em 28/09/2024 às 09:41 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802927-50.2024.8.12.0002 e código JoToWerH.

privado de assistência à saúde coletivo empresarial, previsto no artigo 5º desta resolução.

§1º Para a contratação de plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial, o empresário individual deverá apresentar documento que confirme a sua inscrição nos órgãos competentes, bem como sua regularidade cadastral junto à Receita Federal, e outros que vierem a ser exigidos pela legislação vigente, pelo período mínimo de seis meses, de acordo com sua forma de constituição.

§2º Para a manutenção do contrato coletivo empresarial, o empresário individual deverá conservar a sua inscrição nos órgãos competentes, bem como sua regularidade cadastral junto à Receita Federal, de acordo com sua forma de constituição.

Art. 15. Plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão é aquele que oferece cobertura da atenção prestada à população que mantenha vínculo com as seguintes pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial:

I – conselhos profissionais e entidades de classe, nos quais seja necessário o registro para o exercício da profissão;

II – sindicatos, centrais sindicais e respectivas federações e confederações;

III – associações profissionais legalmente constituídas;

IV - cooperativas que congreguem membros de categorias ou classes de profissões regulamentadas;

V - caixas de assistência e fundações de direito privado que se enquadrem nas disposições desta resolução; e

VI - entidades previstas na Lei n° 7.395, de 31 de outubro de 1985, e na Lei n° 7.398, de 4 de novembro de 1985.

§1º Poderá ainda aderir ao plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão, desde que previsto contratualmente, o grupo familiar do beneficiário titular até o terceiro grau de parentesco consanguíneo, até o segundo grau de parentesco por afinidade, cônjuge ou companheiro.

§2º A adesão do grupo familiar a que se refere o §1º deste artigo dependerá da participação do beneficiário titular no contrato de plano de assistência à saúde.

§3º Caberá à operadora exigir e comprovar a legitimidade da pessoa jurídica contratante, na forma do caput e a condição de

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LARISSA DITZEL CORDEIRO AMARAL, liberado nos autos em 28/09/2024 às 09:41 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802927-50.2024.8.12.0002 e código JoToWerH.

elegibilidade do beneficiário.

§4º Na forma de contratação prevista no inciso III do artigo 29 desta resolução, caberá tanto à administradora de benefícios quanto à operadora de plano de assistência à saúde comprovar a legitimidade da pessoa jurídica contratante, na forma do caput, e a condição de elegibilidade do beneficiário.

Art. 16. As pessoas jurídicas de que trata o artigo 15 desta resolução só poderão contratar plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão quando constituídas há pelo menos um ano, exceto as pessoas jurídicas previstas nos incisos I e II daquele artigo.

Essa mesma resolução normativa cuidou de regrar, nos artigos 23 e 24, não só as hipóteses e condições de exclusão e suspensão de beneficiários dos **planos privados de assistência à saúde coletivos**, como também a possibilidade de rescisão unilateral dessa modalidade de contratação. Confira-se:-

Art. 23. As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes.

Art. 24. Caberá à pessoa jurídica contratante solicitar a suspensão ou exclusão de beneficiários dos planos privados de assistência à saúde coletivos.

Parágrafo único. As operadoras só poderão excluir ou suspender a assistência à saúde dos beneficiários, sem a anuência da pessoa jurídica contratante, nas seguintes hipóteses:

I - fraude; ou

II - por perda dos vínculos do titular previstos nos artigos 5° e 15 desta resolução, ou de dependência, desde que previstos em regulamento ou contrato, ressalvado o disposto nos artigos 30 e 31 da Lei n° 9.656, de 1998; ou

III - a pedido do beneficiário.

Note-se que a despeito da referida resolução condicionar a

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LARISSA DITZEL CORDEIRO AMARAL, liberado nos autos em 28/09/2024 às 09:41 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802927-50.2024.8.12.0002 e código JoToWerH.

exclusão e/ou a suspensão de beneficiários dos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial **à anuência da pessoa jurídica contratante nas hipóteses de fraude ou por perda dos vínculos do titular ou de dependência e desde que previstos em regulamento ou contrato**, na **rescisão e/ou cancelamento unilateral,** a única ressalva, contudo, é que a possibilidade encontre previsão expressa no contrato celebrado entre as partes.

Aliás, a Terceira Turma do STJ, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.119.370/PE, realizado em 17/dezembro/2010, sob a relatoria da Excelentíssima Senhora Ministra Nancy Andrighi, já havia sufragado entendimento no sentido de **que a Lei nº 9.656/98 não teria o condão de impedir a rescisão unilateral dos contratos coletivos de saúde suplementar celebrados entre as operadoras de planos de saúde e as empresas**. Confira-se:-

SEGURO SAÚDE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO ESTIPULADO ENTRE A SEGURADORA E PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, EMPREGADORA DA RECORRIDA. RESILIÇÃO DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DA MANUTENÇÃO DO CONTRATO, NAS MESMAS CONDIÇÕES, COM RELAÇÃO À BENEFICIÁRIA, CONSIDERADA INDIVIDUALMENTE. *1.* ***A Lei 9.656/98 não impede a resilição dos chamados contratos coletivos de assistência médica, celebrados entre as operadoras de planos de saúde e as empresas****. Na hipótese dos autos, essa afirmação é ainda mais significativa, porque o contrato coletivo do qual a recorrida era beneficiária foi firmado entre as recorrentes e o TRE/PE pessoa jurídica de direito público interno e, portanto, submetida às normas que regem o direito administrativo. 2. Mesmo que em algumas situações o princípio da autonomia da vontade ceda lugar às disposições cogentes do CDC, não há como obrigar as operadoras de planos de saúde a manter válidas, para um único segurado, as condições e cláusulas previstas em contrato coletivo de assistência à saúde já extinto. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e provido. (REsp 1119370/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/12/2010, DJe 17/12/2010)*

Com efeito, embora não seja possível compelir a operadora

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LARISSA DITZEL CORDEIRO AMARAL, liberado nos autos em 28/09/2024 às 09:41 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802927-50.2024.8.12.0002 e código JoToWerH.

de plano de saúde a manter, por exemplo, um ex-empregado e/ou ex-beneficiário em plano coletivo extinto, com as mesmas condições e valores anteriormente vigentes na hipótese da rescisão do contrato entre a operadora do plano de saúde e a ex-empregadora, estipulante do plano de saúde coletivo, **é facultado ao beneficiário migrar para um plano individual ou familiar sem cumprimento de novo período de carência**, se assim demonstrar interesse, sujeitando-se, contudo, às regras e valores específicos pertinentes à nova modalidade contratual buscada e desde que a operadora comercialize esse tipo de plano.

É o que se extrai da redação dos artigos 1º, 2º e 3º da Resolução CONSU nº 19/1999, que disciplinou a absorção do universo de consumidores pelas operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde que operam ou administram planos coletivos que vierem a ser liquidados ou encerrados. Confiram-se:-

Art. 1º ***As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência****. § 1º Considera-se, na contagem de prazos de carência para essas modalidades de planos, o período de permanência do beneficiário no plano coletivo cancelado. § 2º Incluem-se no universo de usuários de que trata o caput todo o grupo familiar vinculado ao beneficiário titular.*

Art. 2º Os beneficiários dos planos ou seguros coletivos cancelados deverão fazer opção pelo produto individual ou familiar da operadora no prazo máximo de trinta dias após o cancelamento. *Parágrafo único. O empregador deve informar ao empregado sobre o cancelamento do benefício em tempo hábil ao cumprimento do prazo de opção de que trata o caput.*

Art. 3º Aplicam-se as disposições desta Resolução somente às operadoras que mantenham também plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar.*" (grifei e destaquei)*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LARISSA DITZEL CORDEIRO AMARAL, liberado nos autos em 28/09/2024 às 09:41 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802927-50.2024.8.12.0002 e código JoToWerH.

A flexibilidade das regras para rescisão unilateral da contratação para **os planos coletivos empresariais** se justifica, na medida em que nestes a empresa ou o órgão público possui(em) melhores condições de identificar logo na fase pré-contratual o grupo de usuários que será abrangido pela cobertura contratada, uma vez que detém em seus arquivos os dados pessoais desses empregados e/ou servidores para serem fornecidos à operadora contratada, facilitando, por conseguinte, os cálculos atuariais em relação aos riscos assumidos pelas empresas contratadas. Consequência disso, estes grupos de beneficiários certamente arcarão com valores (mensalidades) inferiores àqueles suportados pelos usuários de planos individuais ou familiares.

Não se pode olvidar ainda, *ad argumentantum*, que eventuais oscilações durante a execução contínua desse tipo de contratação poderão, inclusive, ensejar um desequilíbrio econômico-financeiro à empresa contratrada, de modo a lhe possibilitar não só repactuar valores com as empresas estipulantes, como também, decidir pela resilição da avença, diferentemente do que ocorre nos contratos relativos aos **plano de saúde individual ou familiar** que estão mais engessados com critérios mais rígidos e protetivos, uma vez que neles não há livre negociação de preço da mensalidade que é paga diretamente pelo beneficiário com base nos valores praticados pelo mercado e previamente aprovados pela ANS. Em suma, diante da diferença substancial entre os riscos, formato e preços entre **planos coletivos empresariais** e **planos individuais ou familiares**, não se pode exigir naqueles os mesmos critérios rígidos e protetivos nestes últimos.

Nesse mesmo diapasão tem sido a jurisprudência há muito consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça:-

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EXTINÇÃO DO PLANO FIRMADO ENTRE OPERADORA E ESTIPULANTE. POSSIBILIDADE DE MIGRAÇÃO PARA CONTRATO INDIVIDUAL/FAMILIAR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. ***Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, cancelado o contrato de plano de***

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LARISSA DITZEL CORDEIRO AMARAL, liberado nos autos em 28/09/2024 às 09:41 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802927-50.2024.8.12.0002 e código JoToWerH.

saúde coletivo, não há fundamento legal para obrigar a seguradora a manter o ex-empregado da estipulante no plano de saúde coletivo extinto, com as mesmas condições e valores anteriormente vigentes. 2. O segurado que tiver interesse em manter os serviços assistenciais da antiga operadora tem o direito de migrar para seguro-saúde individual ou familiar, sem imposição de novos prazos de carência, o que implica, porém, aceitar as novas regras e encargos inerentes a essa modalidade contratual*. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1713128 - SP (2020/0139742- 2) RELATOR : MINISTRO RAUL ARAÚJO Brasília, 18 de dezembro de 2023)*

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. OPERADORA. RESILIÇÃO UNILATERAL. LEGALIDADE. ESTIPULANTE. FALÊNCIA. INADIMPLEMENTO. BENEFICIÁRIO APOSENTADO. PLANO INDIVIDUAL. MIGRAÇÃO. PREÇO DAS MENSALIDADES. VALORES DE MERCADO. ADAPTAÇÃO. [....]3. ***Quando houver o cancelamento do plano privado coletivo de assistência à saúde, deve ser permitido que empregados ou ex-empregados migrem para planos individuais ou familiares, sem o cumprimento de carência, desde que a operadora comercialize tais modalidades de plano (arts. 1º a 3º da Res.-CONSU nº 19/1999).*** *4. A Segunda Seção desta Corte Superior já decidiu que o ex-empregado aposentado não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano privado de assistência à saúde vigente à época da aposentadoria se o modelo para os trabalhadores ativos sofreu modificações (Tema Repetitivo/STJ nº 1034). 5. Não há falar em manutenção do mesmo valor das mensalidades aos beneficiários que migram do plano coletivo empresarial para o plano individual, haja vista as peculiaridades de cada regime e o tipo contratual (atuária e massa de beneficiários), que geram preços diferenciados. O que deve ser evitado é a abusividade, tomando-se como referência o valor de mercado da modalidade contratual. 6. Rescindido o contrato de plano de saúde coletivo, o beneficiário possui direito à migração para plano individual ou familiar quando comercializados pela operadora, sem o cumprimento de novos prazos de carência, desde que se submeta às novas regras e aos encargos inerentes a essa modalidade contratual.(RECURSO ESPECIAL Nº 1884465 - SP (2020/0174351-8) RELATOR : MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA. Julgamento em 08 de novembro de 2022)*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LARISSA DITZEL CORDEIRO AMARAL, liberado nos autos em 28/09/2024 às 09:41 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802927-50.2024.8.12.0002 e código JoToWerH.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO NOBRE DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. 1. ***Nos termos jurisprudência do STJ, rescindido o contrato coletivo antes existente entre operadora e empregadora, o beneficiário possui direito a ser incluído no novo plano de saúde coletivo eventualmente contratado pela ex-empregadora ou fazer a migração para plano individual ou familiar (quando comercializados pela operadora), sem cumprimento de novos prazos de carência, desde que se submeta às novas regras e encargos inerentes a essa modalidade contratual.*** *Precedentes. 2. Agravo interno desprovido." (AgInt no AREsp nº 1.720.112/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, DJe de 20/11/2020)*

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL (CPC/2015). RESCISÃO DO PLANO ENTRE A OPERADORA E A EX-EMPREGADORA. PRETENSÃO DO DEMANDANTE DE MANUTENÇÃO DO PLANO NAS MESMAS CONDIÇÕES DE COBERTURA E PAGAMENTO. PRETENSÃO DE ESCOLHER A OPERADORA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Controvérsia que cinge-se a determinar se ao ex-empregado deve ser assegurada a sua manutenção como beneficiário de plano de saúde coletivo extinto por resilição de iniciativa da empregadora estipulante. 2. ***Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, cancelado o contrato de plano de saúde coletivo, não há fundamento legal para obrigar a seguradora a manter o ex-empregado da estipulante no plano de saúde coletivo extinto, com as mesmas condições e valores anteriormente vigentes. 3. O segurado que tiver interesse em manter os serviços assistenciais da antiga operadora tem o direito de migrar para seguro saúde individual ou familiar, sem imposição de novos prazos de carência, o que implica, porém, aceitar as novas regras e encargos inerentes à essa modalidade contratual.*** *4. Precedentes específicos das Turmas de Direito Privado do STJ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO". (AgInt no REsp nº 1.791.515/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 26/2/2020)*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LARISSA DITZEL CORDEIRO AMARAL, liberado nos autos em 28/09/2024 às 09:41 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802927-50.2024.8.12.0002 e código JoToWerH.

No caso invectivado, contudo, além da Autora não ter sido validamente notificada pelas RR., na medida em que o comunicado de fl. 54, enviado pela Unimed Norte de Minas, não se presta para esse fim[14], não podia ter sido privada da cobertura contratual enquanto realizava acompanhamento pré natal médico continuado e avançado (Tema Repetitivo 1.082, STJ).

Observe-se, o contrato em questão, está em vigência desde o dia 14/abril/2023 e a consumidora goza da cobertura desde o mês de outubro daquele mesmo ano, de modo que a interrupção abrupta do tratamento, pela recusa imotivada da prestadora de serviço, a despeito de encontrar-se em acompanhamento médico, consubstancia abuso e ilicitude.

Corolário disso, independentemente da identificação da regularidade ou não da rescisão e/ou cancelamento do plano entre a estipulante e a operadora do plano de saúde da Autora, o simples fato de encontrar-se em acompanhamento médico afasta, por ora, a possibilidade de rescisão do plano de saúde, pela aplicação analógica da regra dos artigos 13, parágrafo único, inciso III e 35-E, inciso IV, todos da Lei nº 9.656/98, que assim estabelecem:-

Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

(...)

III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular.

Art. 35-E. A partir de 5 de junho de 1998, fica estabelecido

---

[14] *não só por desatender os requisitos de uma notificação e os requisitos exigidos pela ANS, mas sobretudo por ter tido seu conteúdo contestado/impugnado pela própria Administradora do plano de saúde da Autora (Allcare)*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LARISSA DITZEL CORDEIRO AMARAL, liberado nos autos em 28/09/2024 às 09:41 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802927-50.2024.8.12.0002 e código JoToWerH.

para os contratos celebrados anteriormente à data de vigência desta Lei que:

(...)

IV - é vedada a interrupção de internação hospitalar em leito clínico, cirúrgico ou em centro de terapia intensiva ou similar, salvo a critério do médico assistente.

Por óbvio, tais comandos normativos têm por escopo teleológico e finalístico evitar que os beneficiários sejam surpreendidos pela ruptura repentina de seus planos de saúde em momentos de vulnerabilidade e/ou fragilidade de seu quadro de saúde, sobretudo quando estejam realizando tratamento contínuo que os coloque em posição extremamente desvantajosa na relação contratual.

Como é cediço, *"a liberdade de contratar não é absoluta, devendo ser exercida nos limites e em razão da função social dos contratos, notadamente em casos como o presente, cujos bens protegidos são a saúde e a vida dos beneficiários, os quais se sobrepõem a quaisquer outros de natureza eminentemente contratual, impondo-se a manutenção do vínculo contratual entre as partes até que os referidos beneficiários encerrem o respectivo tratamento médico"* [15]

Nesse sentido é o teor do Enunciado 23 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Conselho da Justiça Federal (CJF):

"A função social do contrato, prevista no art. 421 do novo Código Civil, não elimina o princípio da autonomia contratual, mas atenua ou reduz o alcance desse princípio quando presentes interesses metaindividuais ou interesse individual relativo à dignidade da pessoa humana.".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito já inviabilizava a rescisão unilateral imotivada pelas operadoras de planos de saúde nas hipóteses em que o usuário se encontrasse em pleno tratamento durante sua vigência. Confira-se:-

[15] REsp n. 1.818.495/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8.10.2019, DJe de 11.10.2019.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LARISSA DITZEL CORDEIRO AMARAL, liberado nos autos em 28/09/2024 às 09:41 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802927-50.2024.8.12.0002 e código JoToWerH.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO COMINATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. ***1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, ainda que seja possível a rescisão unilateral imotivada de plano de saúde, independentemente do regime de contratação (coletivo ou individual), deve ser mantida a cobertura enquanto perdurar o tratamento médico a que esteja submetido o beneficiário.*** *2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.918.943/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9.5.2022)*

*CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO MÉDICO. DECISÃO MANTIDA. 1. "****Em se tratando de contrato coletivo de plano de saúde, mesmo não sendo aplicável o art. 13 da Lei 9.656/1998, as cláusulas previamente estabelecidas não podem proteger práticas abusivas e ilegais, como seria a do cancelamento promovido no momento em que o segurado mais necessita da cobertura, por estar em tratamento de doença grave"*** *(AgInt no REsp 1.954.897/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 1º/2/2022). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.975.011/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25.4.2022, DJe de 28.4.2022)*

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESILIÇÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO. EXCEÇÃO. REEXAME DE PROVAS E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS PACTUADAS ENTRE AS PARTES. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.1. ***A despeito da possibilidade de o plano de saúde coletivo ser rescindido ou suspenso imotivadamente (após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de sessenta dias (artigo 17 da Resolução Normativa ANS 195/2009), no caso de usuário internado, independentemente do regime de contratação do plano de saúde (coletivo ou individual), dever-se-á aguardar a conclusão do tratamento médico***

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LARISSA DITZEL CORDEIRO AMARAL, liberado nos autos em 28/09/2024 às 09:41 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802927-50.2024.8.12.0002 e código JoToWerH.

garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física para se pôr fim à avença. *Precedentes. [...] 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.762.780/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4.4.2022, DJe de 7.4.2022)*

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO. PACIENTE EM TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. MANUTENÇÃO. *SÚMULAS 7 E 83/STJ. 1. Em se tratando de contrato coletivo de plano de saúde, mesmo não sendo aplicável o art. 13 da Lei 9.656/1998, as cláusulas previamente estabelecidas não podem proteger práticas abusivas e ilegais, como seria a do cancelamento promovido no momento em que o segurado mais necessita da cobertura, por estar em tratamento de doença grave. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.954.897/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14.12.2021, DJe de 1º.2.2022)*

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. OBRIGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ATÉ ALTA MÉDICA*. IMPUGNAÇÃO DA SÚMULA 568 DO STJ. PRECEDENTE ANTERIOR AOS MENCIONADOS NA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE. 1.* ***É inviável a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde individual ou coletivo, pela operadora, durante o período em que o beneficiário estiver submetido a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência e/ou incolumidade física.*** *Precedentes. 2. A aplicação da Súmula 568/STJ é devidamente impugnada quando a parte agravante demonstra, de forma fundamentada, que o entendimento esposado na decisão agravada não se aplica à hipótese em concreto ou, ainda, que é ultrapassado, o que se dá mediante a colação de arestos mais recentes do que aqueles mencionados na decisão hostilizada, o que não ocorreu na hipótese. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.879.753/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13.12.2021, DJe de 15.12.2021)*

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ***PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL.***

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LARISSA DITZEL CORDEIRO AMARAL, liberado nos autos em 28/09/2024 às 09:41 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802927-50.2024.8.12.0002 e código JoToWerH.

OPERADORA. RESILIÇÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO. TRATAMENTO MÉDICO. FINALIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. NORMAS. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA. *[...] 2. A operadora de plano de saúde, apesar de poder promover a resilição unilateral do plano de saúde coletivo, não poderá deixar ao desamparo os usuários que se encontram sob tratamento médico. Interpretação sistemática e teleológica dos arts. 8º, § 3º, "b", e 35-C da Lei nº 9.656/1998 e 18 da RN nº 428/2017 da ANS, conjugada com os princípios da boa-fé, da função social do contrato, da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.849.475/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13.12.2021, DJe de 16.12.2021)*

*AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. RESCISÃO UNILATERAL PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE COLETIVO. DESNECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE PLANO INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO E PACIENTE EM COMA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 3. Ademais, "**a resilição unilateral do plano de saúde, mediante prévia notificação, não obstante seja em regra válida, revela-se abusiva quando realizada durante o tratamento médico que possibilite a sobrevivência ou a manutenção da incolumidade física do beneficiário ou dependente"** (AgInt no REsp n. 1.903.742/SP, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 15/4/2021). [...] 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.950.610/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22.11.2021, DJe de 25.11.2021)*

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. ***CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESILIÇÃO UNILATERAL. OPERADORA QUE NÃO COMERCIALIZA PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL E FAMILIAR****. CDC. LEI 9.656/1998. ART. 3º DA RESOLUÇÃO CONSU Nº 19/1999. DIÁLOGO DAS FONTES.* ***AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ABUSIVIDADE. DIREITO À PORTABILIDADE DE CARÊNCIA RECONHECIDO****.*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LARISSA DITZEL CORDEIRO AMARAL, liberado nos autos em 28/09/2024 às 09:41 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802927-50.2024.8.12.0002 e código JoToWerH.

JULGAMENTO: CPC/15.1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação do dano moral ajuizada em 11/11/2015, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 05/02/2018 e atribuído ao gabinete em 11/05/2018. 2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a obrigação de a operadora de plano de saúde coletivo por adesão, depois de resilir unilateralmente o contrato firmado com a pessoa jurídica a que estão vinculados os beneficiários, reintegrá-los no mesmo plano, diante da inexistência, em sua carteira de serviços, de plano individual ou familiar, ou adotar outra providência que lhes assegure a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente. 3. A ANS, no exercício de seu poder normativo e regulamentar acerca dos planos de saúde coletivos - ressalvados, apenas, os de autogestão -, deve observar os ditames do CDC. 4. Se, de um lado, a Lei 9.656/1998 e seus regulamentos autorizam a operadora do seguro de saúde coletivo por adesão a não renovar o contrato; de outro lado, o CDC impõe que os respectivos beneficiários, que contribuíram para o plano, não fiquem absolutamente desamparados, sem que lhes seja dada qualquer outra alternativa para manter a assistência a sua saúde e de seu grupo familiar. 5. A interpretação puramente literal do art. 3º da Resolução CONSU nº 19/1999 agrava sobremaneira a situação de vulnerabilidade do consumidor que contribuiu para o serviço e favorece o exercício arbitrário, pelas operadoras de seguro de saúde coletivo, do direito de não renovar o contrato celebrado por adesão, o que não tolera o CDC, ao qual estão subordinadas. 6. O diálogo das fontes entre o CDC e a Lei 9.656/1998, com a regulamentação dada pela Resolução CONSU nº 19/1999, exige uma interpretação que atenda a ambos os interesses: ao direito da operadora, que pretende se desvincular legitimamente das obrigações assumidas no contrato celebrado com a estipulante, corresponde o dever de proteção dos consumidores (beneficiários), que contribuíram para o seguro de saúde e cujo interesse é na continuidade do serviço. 7. Na ausência de norma legal expressa que resguarde o consumidor na hipótese de resilição unilateral do contrato coletivo pela operadora, há de se reconhecer o direito à portabilidade de carências, permitindo, assim, que os beneficiários possam contratar um novo plano de saúde, observado o prazo de permanência no anterior, sem o cumprimento de novos períodos de carência ou de cobertura parcial temporária e sem custo adicional pelo exercício do direito. 8. Hipótese em que se reconhece a abusividade da resilição pela operadora do plano de saúde, por inobservância do dever de notificação prévia, e, por conseguinte, a prorrogação dos efeitos do contrato, com a

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LARISSA DITZEL CORDEIRO AMARAL, liberado nos autos em 28/09/2024 às 09:41 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802927-50.2024.8.12.0002 e código JoToWerH.

determinação de que os recorrentes sejam devidamente comunicados da extinção do vínculo contratual a fim de que possam exercer o direito de requerer a portabilidade de carência, nos termos da norma regulamentadora. 9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp n. 1.739.907/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18.8.2020, DJe de 26.8.2020) 8. A outra situação apta a exonerar a operadora de continuar a custear os cuidados assistenciais prestados ao usuário submetido a internação ou a tratamento de saúde - iniciados antes do cancelamento do pacto coletivo - consiste na existência de contratação de novo plano pelo empregador com outra operadora. Deveras, consoante cediço nesta Corte, em havendo o cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde coletivo empresarial, "é recomendável ao empregador promover a pactuação de nova avença com outra operadora, evitando-se prejuízos aos seus empregados (ativos e inativos), que não precisarão se socorrer da portabilidade ou da migração a planos individuais, de custos mais elevados" (EDcl no AgInt no REsp n. 1.941.254/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29.11.2021, DJe de 1º.12.2021; e REsp n. 1.846.502/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20.4.2021, DJe de 26.4.2021).

Tanto não bastasse, no julgamento do dia 22/06/2022, do Recurso Especial Representativo de Controvérsia nº 1.842.751 - RS (2019/0145595-3), o Superior Tribunal de Justiça consolidou, definitivamente, o entendimento anterior no sentido de assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos ao usuário do plano de saúde em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, condicionado, apenas, à assiduidade da contraprestação devida, firmando, assim, tese jurídica (Tema 1082) para fins do artigo 1.036 do CPC, que se encontra assim ementada:

*"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE. 1. Tese jurídica firmada para fins do artigo 1.036 do CPC: **"A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a***

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LARISSA DITZEL CORDEIRO AMARAL, liberado nos autos em 28/09/2024 às 09:41 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802927-50.2024.8.12.0002 e código JoToWerH.

continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida." *2. Conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares, sobressai o entendimento de que a impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário - ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física - também alcança os pactos coletivos. Isso porque, em havendo usuário internado ou em pleno tratamento de saúde, a operadora, mesmo após exercido o direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8º, § 3º, alínea "b", e 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021, que reproduz, com pequenas alterações, o teor do artigo 18 contido nas Resoluções Normativas DC/ANS n. 428/2017, 387/2015 e 338/2013. 4. A aludida exegese também encontra amparo na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o que permite concluir que, ainda quando haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade. 5. Caso concreto: (i) o pai do menor aderiu, em 7.2.2014, ao seguro-saúde coletivo empresarial oferecido pela ré, do qual a sua empregadora era estipulante; (ii) no referido pacto, havia cláusula expressa prevendo que, após o período de 12 meses de vigência, a avença poderia ser rescindida imotivadamente por qualquer uma das partes, mediante notificação por escrito com no mínimo 60 dias de antecedência; (iii) diante da aludida disposição contratual, a operadora enviou carta de rescisão ao estipulante, indicando o cancelamento da apólice em 16.12.2016; (iv) desde 10.11.2016, foi constatado que o menor - à época, recém-nascido - é portador de cardiopatia congênita, além de sequelas provenientes de infecção urinária causada por superbactéria, o que reclama o acompanhamento contínuo de cardiologista e de nefrologista a fim de garantir a sua sobrevivência; (v) em razão do cancelamento unilateral da apólice coletiva, o menor e o seu genitor - dependente e titular - ajuizaram a presente demanda, em*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LARISSA DITZEL CORDEIRO AMARAL, liberado nos autos em 28/09/2024 às 09:41 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802927-50.2024.8.12.0002 e código JoToWerH.

15.12.2016, postulando a manutenção do seguro-saúde enquanto perdurar a necessidade do referido acompanhamento médico e respectivo tratamento de saúde; (vi) em 15.12.2016, foi deferida antecipação da tutela jurisdicional pela magistrada de piso determinando que a ré custeasse o tratamento médico e hospitalar do menor (fls. 26-27), o que ensejou a reativação do plano de saúde em 19.12.2016; e (vii) a sentença - mantida pelo Tribunal de origem - condenou a ré a revogar o cancelamento da apólice objeto da lide, restabelecendo, assim, o seguro-saúde e as obrigações pactuadas. 6. Diante desse quadro, merece parcial reforma o acórdão estadual para se determinar que, observada a manutenção da cobertura financeira dos tratamentos médicos do usuário dependente que se encontrem em curso, seja o coautor (usuário titular) devidamente cientificado, após a alta médica, da extinção do vínculo contratual, contando-se, a partir de então, o prazo normativo para o exercício do direito de requerer a portabilidade de carência, nos termos da norma regulamentadora, salvo se optar por aderir a novo plano coletivo eventualmente firmado pelo seu atual empregador. 7. Recurso especial parcialmente provido.

Como se vê, **os planos de saúde coletivos não podem ser cancelados, de forma unilateral, enquanto o paciente estiver em tratamento de doença grave (Tema 1.082)** e mesmo após exercício regular do direito à rescisão unilateral do plano coletivo, a operadora deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos ao usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que arque integralmente com a contraprestação devida.

No caso *sub examinem*, como já destacado alhures, a segurada sequer foi prévia e regularmente notificada pela operadora do plano de saúde sobre a extensão do "bloqueio" e a consequente supressão dos direitos que lhe são conferidos pelo contrato de prestação de serviço, assim como sobre sua manutenção durante a realização dos tratamentos indispensáveis à manutenção e/ou restabelecimento de seu quadro clínico; a negativa de cobertura, portanto, na hipótese, se mostra abusiva e excessivamente onerosa para a consumidora, diante da natureza da contratação e das peculiariedades do caso, pois a segurada, mesmo cumprindo a prestação contratual que lhe cabe, foi surpreendida pela

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LARISSA DITZEL CORDEIRO AMARAL, liberado nos autos em 28/09/2024 às 09:41 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802927-50.2024.8.12.0002 e código JoToWerH.

recusa da contratada a cumprir aquela que lhe cabe.

Demais disso, *ad argumentandum tantum*, ainda, que existisse conflito entre o interesse do beneficiário(a) do plano e a administradora, prevaleceria o daquele(a), diante do que dispõe o artigo 47 do diploma consumerista.

Por conseguinte, encerrada a instrução e comprovada a irregularidade da rescisão unilateral e o amparo legal a permanência da contratação de seu plano de saúde celebrado com as RR, procede a pretensão autoral, devendo ser tornada definitiva a liminar (fls. 90/101).

Quanto ao pedido de ***indenização por danos morais***, não tenho dúvidas que a tentativa abrupta e indevida da primeira Ré em rescindir unilateralmente a avença num momento extremamente sensível da vida de qualquer gestante a exigir um acompanhamento rigoroso em seu pré-natal, causou-lhe enorme abalo psíquico, justificador de uma reparação pecuniária.

Que o dano moral puro (consistente na lesão a um interesse de ordem extrapatrimonial, contido nos direitos da personalidade ou nos atributos da pessoa, sem atingir sua esfera patrimonial) é indenizável, já não se discute mais após o advento da Constituição Federal de 1988.

Não se pode negar que situação semelhante a versada nos autos causa danos de ordem moral. São presumíveis os desconfortos e sofrimentos experimentados pela Autora que, no momento que mais necessitava de amparo de seu plano de saúde durante sua gestação, teve que passar pelo desgaste de ingressar com uma ação judicial para fazer valer o seu direito material de ser mantida no plano de saúde contrato com a operadora Ré, circunstância que indubitavelmente causou-lhe transtornos de ordem emocional. São os chamados danos *in re ipsa*, ou seja, que decorrem do próprio fato e independem de prova. A este respeito valho-me novamente dos ensinamentos de Sérgio Cavalieri Filho:

"Essa é outra questão que enseja alguma polêmica nas ações de indenização. Como, em regra, não se presume o dano, há

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LARISSA DITZEL CORDEIRO AMARAL, liberado nos autos em 28/09/2024 às 09:41 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802927-50.2024.8.12.0002 e código JoToWerH.

decisões no sentido de desacolher a pretensão indenizatória por falta de prova do dano moral.

Entendemos, todavia, que por se tratar de algo imaterial ou ideal, a prova do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza ou a humilhação, através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorna à fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais.

Neste ponto a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano moral está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. Se a ofensa é grave e de repercussão, por si só justifica a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado. Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo de tal modo que provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que decorre das regras da experiência comum. Assim, por exemplo, provada a perda de um filho, do cônjuge, ou de outro ente querido, não há que se exigir a prova do sofrimento, porque isso decorre do próprio fato de acordo com as regras de experiência comum; provado que a vítima teve seu nome aviltado, ou a sua imagem vilipendiada, nada mais ser-lhe-á exigido provar, por isso que o dano moral está in re ipsa; decorre inexoravelmente da gravidade do próprio fato ofensivo, de sorte que, provado o fato, provado está o dano moral'[16].

Noutro vértice, a despeito da responsabilidade solidária das RR., neste caso específico, tendo somente a primeira Ré dado causa à tentativa de rescisão abrupta e unilateral da avença, tenho que somente ela deva responder pelos prejuízos de ordem imaterial experimentados pela Autora.

No que se refere ao valor da reparação, à vista da inexistência de parâmetros legais para fixação do valor do dano extrapatrimonial, o julgador deve observar os princípios da

[16] Ob. cit, p. 108.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LARISSA DITZEL CORDEIRO AMARAL, liberado nos autos em 28/09/2024 às 09:41 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802927-50.2024.8.12.0002 e código JoToWerH.

proporcionalidade e razoabilidade[17]. Outrossim, deve atentar para a natureza jurídica da indenização[18], que deve constituir uma pena ao causador do dano e, concomitantemente, compensação ao lesado, além de cumprir seu cunho pedagógico sem caracterizar enriquecimento ilícito.

Nesse sentido é a lição de Caio Mário da Silva Pereira (*in Responsabilidade Civil*, 4ª ed., 1993, p. 60), nos seguintes termos:

"A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva".

Sergio Cavalieri Filho, na obra *Programa de Responsabilidade Civil*, 8ª ed., Editora Atlas S/A, 2009, p. 93, ao tratar do arbitramento do dano moral, assim se manifestou:

"Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. A razoabilidade é o critério que permite cotejar meios e fins, causas e conseqüências, de modo a aferir a lógica da decisão. Para que a decisão seja razoável é necessário que a conclusão nela estabelecida seja adequada aos motivos que a determinaram; que os meios escolhidos sejam compatíveis com os fins visados; que a sanção seja proporcional ao dano. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral,

[17] REsp 797.836/MG, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, j. 02.05.2006.
[18] *"A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. (...). Penal, constituindo uma sanção imposta ao ofensor. (...). Satisfatória ou compensatória, (...) a reparação pecuniária visa proporcionar ao prejudicado uma satisfação que atenue a ofensa causada." (DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. 16ª ed., São Paulo: Saraiva, 2002, p. 94, V. 7)*
"Segundo nosso entendimento a indenização da dor moral, sem descurar desses critérios e circunstâncias que o caso concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo objetivo: caráter compensatório e função punitiva da sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o agente causador do dano ao pagamento de certa importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo da prática futura de atos semelhantes; b) compensar a vítima com uma importância mais ou menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez, pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e humilhação impostas." (STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil, 6ª ed., São Paulo: RT, 2004, p. 1709.)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LARISSA DITZEL CORDEIRO AMARAL, liberado nos autos em 28/09/2024 às 09:41 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802927-50.2024.8.12.0002 e código JoToWerH.

deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes".

Partindo de tais premissas, tenho que a reparação buscada deve ser fixada no valor de **R$ 7.000,00 (sete mil reais)**, considerando as condições econômicas e sociais dos envolvidos; os limites do pedido (fl. 67) diante da impossibilidade de fixação de valor superior por força do princípio da congruência; a lesividade da falta cometida; e principalmente que a verba não deve enriquecer ilicitamente a Autora, tampouco causar constrangimento econômico da Ré, sem perder de vista o caráter punitivo-pedagógico.

ISSO POSTO, com base nos artigos 487, inciso I, 497, do Código de Processo Civil, artigos 186 e 927 do Código Civil, 5º, incisos V e X da Constituição Federal, julgo procedente o pedido inicial, para:

a) tornar definitiva a liminar concedida (fls. 90/101), condenando solidariamente a **Unimed Norte de Minas e/ou Unimed Montes Claros – Cooperativa de Trabalho Médico Ltda** e a **Allcare Administradora de Benefícios São Paulo Ltda** a manterem a contratação entre as partes assegurando a Autora *"a cobertura dos custos médico-hospitalares durante o pré-natal, parto e ainda a garantia do ingresso do recém-nascido, tão logo seu nascimento, como dependente da Autora no plano de saúde, sem exigência de carência e sem restrição de cobertura durante o primeiro mês" (sic),* até o final de seu tratamento e/ou que sobrevenha decisão em sentido contrário, sob pena de incidência da multa já fixada.

ii) condenar a **Unimed Norte de Minas e/ou Unimed Montes Claros Cooperativa de Trabalho Médico Ltda,** solidariamente, a pagarem à Autora, a quantia de **R$ 7.000,00 (sete mil reais), à título de indenização pelos danos morais**, valor este que deverá ser corrigido monetariamente, pelo INPC/IBGE, desde a data desta sentença, e acrescido de juros moratórios, no percentual de 12% (doze pontos percentuais) ao ano, a partir do trânsito em julgado, até o seu efetivo adimplemento;

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LARISSA DITZEL CORDEIRO AMARAL, liberado nos autos em 28/09/2024 às 09:41 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802927-50.2024.8.12.0002 e código JoToWerH.

iii) condenar solidariamente as Rés ao pagamento das custas e despesas processuais, e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, o que faço atenta à simplicidade da causa, tempo e atenção exigidos do profissional para seu patrocínio (cf. artigo 85, §2º, CPC).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se, com as cautelas e anotações necessárias.

Dourados/MS, 27 de setembro de 2024.

Larissa Ditzel Cordeiro Amaral
Juíza de Direito

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LARISSA DITZEL CORDEIRO AMARAL, liberado nos autos em 28/09/2024 às 09:41 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802927-50.2024.8.12.0002 e código JoToWerH.